PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5004147-61.2024.8.21.0008/RS

AUTOR: CLAUDINEI DOS SANTOS NOGUEIRA

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

CLAUDINEI DOS SANTOS NOGUEIRA ajuizou ação de obrigação de fazer em face de **IPÊ-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, narrando que é beneficiário do IPE-SAÚDE e goza de cobertura ambulatorial e hospitalar para tratamento de saúde. Relatou, em síntese, que sofre de Neoplasia Hematológica Maligna Tipo Mieloma Múltiplo (CID 10 C90.0) e necessita de tratamento com a medicação DARATUMUMABE. Descreveu o seu histórico clínico e afirmou que recorreu a tratamentos quimioterápicos pelo com "protocolo VCD (BORTEZOMIBE, CICLOFOSFAMIDA e DEXAMETASONA)", com boa resposta terapêutica inicial, mas com recidiva e agravamento posterior e progressão da doença em janeiro de 2024. Sustentou que o médico assistente propôs novo protocolo quimioterápico denominado DRd (DARATUMUMABE, LENALIDOMIDA e DEXAMETASONA), o qual se adequa às condições clínicas do paciente, com nível de indicação padrão ouro para casos análogos. Referiu que, deste protocolo, o réu disponibiliza somente as drogas LENALIDOMINA e DEXAMETASONA, mas se nega a autorizar o fornecimento da droga oncológica DARATUMUMABE. Argumentou que o médico assistente defende que a referida abordagem terapêutica prescrita é a única alternativa compatível com o cenário clínico atual de evolução da doença. Indicou o direito que entende aplicável. Em tutela de urgência, requereu o deferimento do fornecimento da medicação DARATUMUMABE 1800mg, 15ml, conforme descrição da exordial, sob pena de bloqueio de valores. Pugnou pela procedência do pedido para condenar o réu à obrigação de fazer correspondente ao fornecimento da medicação necessária ao tratamento da enfermidade. Requereu AJG. Acostou documentos (evento 1, INIC1).

Deferido o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, bem como o pleito liminar (evento 3, DESPADEC1).

O réu comprovou o cumprimento da liminar autorizando o tratamento com o medicamento Daratumumabe 1800mg (evento 6, OFIC2).

Citada, a parte ré apresentou contestação (evento 8, CONT1) e afirmou que o medicamento não está previsto no protocolo oncológico adotado pelo IPE-SAÚDE para o tratamento da enfermidade. Alegou ausência de cobertura do tratamento requerido. Referiu que a extensão da cobertura pela via judicial ofende o princípio da separação dos poderes. Apresentou alternativas de tratamento dentro da cobertura do plano. Defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Teceu considerações sobre o direito que entende aplicável. Pugnou a improcedência da ação. Acostou documentos.

Houve réplica (evento 11, RÉPLICA1).

Oportunizada a produção de provas (evento 13, DESPADEC1).

As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas (evento 17, PET1, e evento 18, PET1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer onde pretende a autora que seja fornecido o medicamento DARATUMUMABE 1800mg, 15ml, 1 ampola por semana durante as 8 primeiras semanas consecutivas, com novo ciclo de 1 ampola a cada duas semanas durante as próximas 24 semanas consecutivas, e um ciclo final de 32 semanas de tratamento com a aplicação de 1 ampola para cada 30 dias, de forma contínua, por ser portador de Neoplasia Hematológica Maligna Tipo Mieloma Múltiplo (CID 10 C90.0).

Da análise das manifestações das partes, restaram incontroversas a doença da qual o demandante alegou estar acometido e a condição de segurado. A controvérsia pairou sobre o dever de fornecimento do medicamento.

Para solução da questão controvertida, é oportuno consignar que a cobertura do IPE-Saúde quanto a despesas por atendimentos, diagnósticos e tratamentos é disciplinada pelo artigo 4º da Lei Complementar n.º 15.145/2018, que assim dispõe:

> *"Art. 4.º* ***O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.***

§ 1.º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.

§ 2.º Novos procedimentos somente poderão ser incluídos nas tabelas de cobertura do IPE Saúde após aprovação do Órgão Gestor, fundamentado em prévio cálculo financeiro e atuarial.

§ 3.º Para aprimoramento, qualificação, maior abrangência e efetividade de cobertura prestada na área da saúde, mediante prévio estudo técnico e atuarial, o Instituto poderá instituir Planos Especiais, para disponibilizar outros serviços ou procedimentos, cuja participação é opcional, mediante prévia solicitação e mensalidade específica, na forma que dispuserem o regulamento e atos normativos expedidos pelo Instituto.". [grifei]

Nos termos do dispositivo legal transcrito, o demandado é responsável por prover o custeio das despesas com atendimento médico, hospitalar, ambulatorial e laboratorial, bem como por suportar os atos necessários ao diagnóstico e tratamento devido ao usuário do serviço, sendo inequívoco que, entre os aludidos deveres, resta abarcado o fornecimento de medicamentos para tratamento de patologias.

Assim sendo, havendo previsão para tratamento da patologia que acomete o segurado, a limitação prevista no art. 4º, §1º, da Lei Complementar n.º 15.145/2018, segundo a qual restam excluídos da cobertura procedimentos, exames, tratamentos, insumos e materiais que não estejam previstos nas tabelas próprias do instituto, não configura óbice ao fornecimento de medicamento que não esteja previsto nos protocolos da autarquia, consoante o entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. ***IPÊ-SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA DE RIM (CID 10 C64). FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS*** *IPILIMUMABE E NIVOLUMABE. DETERMINAÇÃO DE COBERTURA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. 1. Hipótese em que o demandante, segurado do IPERGS, foi diagnosticado com NEOPLASIA MALIGNA DE RIM - CID 10 C64 (câncer no rim), necessitando das medicações prescritas por seu médico assistente para controle da referida doença, sendo concedida, na origem, tutela de urgência determinando o fornecimento dos fármacos, cuja dispensação fora negada na via administrativa.* ***2. Não há como ser considerada legítima a negativa da Autarquia, já que, naquilo em que o Plano de Saúde oferece cobertura (no caso, oncologia), entende-se que ela deve ser a mais ampla possível, lembrando que, de acordo com o art. 2º da Resolução nº 21/79 são cobertos pelo IPE-SAÚDE "os atendimentos médicos hospitalares, bem como os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento" e que o art. 4º da Lei Complementar nº 15.145/2018 prevê "cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos", não se podendo admitir que o tão-só fato de a medicação prescrita não estar contida em critérios técnicos do IPE-SAÚDE seja óbice à determinação de cobertura.*** *Precedentes deste TJ/RS. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 50477936820228217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 22-06-2022) [grifei]*

APELAÇÃO CIVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. ***IPE-SAÚDE. CONVENIADA PORTADORA DE CÂNCER*** *DE MAMA.* ***INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS:*** *TECENTRIQ (ATEZOLIZUMABE) E ABRAXANE (NAB-PACLITAXEL).* ***APLICABILIDADE DA LEI Nº 15.145/18. PRESCRIÇÃO MÉDICA.*** *ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. ART. 4º DA LEI Nº 15.145/18.* ***AUSÊNCIA DE PREVISÃO. - O art. 4º da Lei Complementar nº 15.145/18, que revogou a Lei nº 12.134/04, dispõe que integram o plano de saúde atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos, exceto os tratamentos não previstos nas tabelas do próprio Instituto (§1º). Ocorre que o entendimento jurisprudencial do STJ e deste TJRS é claro no sentido de que o plano de saúde não pode selecionar o tipo de tratamento dispensado ao segurado.*** *- O art. 30 da Lei nº 15.145/2018 prevê a coparticipação dos usuários do plano de saúde nos casos de consultas, exames complementares, serviços ou procedimentos, porém veda a cobrança quando é caso de internação hospitalar ou de* ***tratamento*** *ambulatorial. E inexistindo previsão específica em relação aos medicamentos, não há falar na possibilidade de cobrança. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50190002320218210027, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 20-04-2022)[grifei]*

À luz dos entendimentos colacionados, não cabe ao plano de saúde eleger o tipo de tratamento a ser dispensado ao segurado, de modo que devem ser analisadas as especificidades do caso concreto para que se verifique se o postulante faz jus ou não ao fornecimento do fármaco pleiteado.

Friso que a definição dos medicamentos a serem utilizados para o tratamento é tarefa que incumbe ao profissional que acompanha o quadro evolutivo do paciente, que conhece o seu histórico e as suas condições pessoais.

Estas, em síntese, são as premissas que entendo indispensáveis para análise do caso em tela.

Ao concreto, o autor comprovou que é portador de Neoplasia Hematológica Maligna Tipo Mieloma Múltiplo (CID 10 C90.0), conforme os laudos médicos que instruíram a inicial (evento 1, LAUDO10).

Igualmente, nos termos dos referido laudo e da prescrição médica (evento 1, RECEIT9), comprovou que necessita fazer uso do medicamento DARATUMUMABE 1800mg, 15ml, na dosagem descrita na exordial, o qual é imprescindível para o seu tratamento.

Ademais, através da juntada de comprovante de rendimentos e de orçamentos dos medicamentos postulados (evento 1, COMP8, e evento 1, OUT22), restou evidenciado que sua renda mensal é incompatível com o valor da medicação, restando inviável o seu custeio.

Nesse contexto, considerando que não há controvérsia sobre o fato de que o autor é segurado do IPE-Saúde, e que o plano possui cobertura para o tratamento da doença indicada na exordial, dúvidas não pairam de que a autarquia deveria fornecer o medicamento postulado pelo demandante, uma vez que é responsável por suportar os atos necessários ao diagnóstico e tratamento devido ao usuário do serviço, nos termos das premissas anteriormente fixadas.

Destarte, demonstrada a necessidade para percepção do fármaco e a responsabilidade da parte ré pelo fornecimento, foi equivocada a negativa administrativa.

Outrossim, ressalto que a decisão que reconhece o direito do segurado a receber o meio adequado para o tratamento de patologia amparada pelo plano de saúde, enquanto corolário do princípio da inafastabilidade da jurisdição, não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE.* ***IPÊ-SAÚDE. CÂNCER. NEGATIVA DO INSTITUTO QUANTO AO MEDICAMENTO A PRETEXTO DE NÃO CONSTAR NO RESPECTIVO PROTOCOLO ONCOLÓGICO. DESCABIMENTO. LIMINAR CONCEDIDA NO 1º GRAU. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, UMA VEZ QUE AO PODER JUDICIÁRIO CUMPRE A APLICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA JURÍDICO SEMPRE QUE INSTADO, NÃO PODENDO SER EXCLUÍDA DA SUA APRECIAÇÃO LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO, SOB PENA DE AFRONTAR DIREITO FUNDAMENTAL GARANTIDO NO ART. 5º, XXXV, DA CF****. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50648971020218217000, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 04-08-2021) [grifei]*

Inarredável, portanto, o julgamento de procedência da ação.

Isso posto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido veiculado por **CLAUDINEI DOS SANTOS NOGUEIRA** em face de **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL** para o fim de condenar o réu ao fornecimento do medicamento DARATUMUMABE 1800mg, 15ml, 1 ampola por semana durante as 8 primeiras semanas consecutivas, com novo ciclo de 1 ampola a cada duas semanas durante as próximas 24 semanas consecutivas, e um ciclo final de 32 semanas de tratamento com a aplicação de 1 ampola para cada 30 dias, de forma contínua, conforme a posologia e a prescrição do médico que assiste o demandante, **confirmando a tutela de urgência deferida.**

Em se tratando de autarquia estadual, a parte ré é isenta do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 5º, I, da Lei n.º 14.634/2014, ressalvadas eventuais despesas.

Fixo honorários advocatícios a serem adimplidos pela parte ré aos procuradores da parte autora no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, §2º e §8º, do CPC.

Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, baixe-se em definitivo.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA RECHDEN LOBATO, Juíza de Direito**, em 27/8/2024, às 16:0:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10066359214v9** e o código CRC **063ca063**.